

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	肌力平衡測試評估 Muscle Strength and Balance Test Assessment				
編號	A31000-Q05-W-A45	制定者	N13 翁岱鈺	公布日期	114 年 07 月 08 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 07 月 08 日
版本/總頁數	第 1.0 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 07 月 08 日

一、目的

護理人員能正確操作肌力平衡測試評估技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

評估病人肌肉力量及肌力平衡情形。

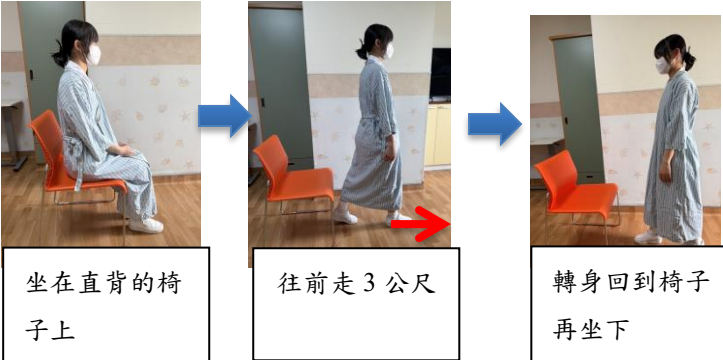
（二）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋肌力平衡測試評估技術的目的、過程及注意事項。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日、無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡或床邊醫療系統）並核對手圈。
2. 洗手。	
3. 拉圍簾，準備病人，協助病人採平躺或坐姿姿勢。	
4. 執行上肢肌力評估：請病人左（右）手肘屈曲，評估者自前臂試圖向下拉（一手扶上臂、一手扳前臂），請病人對抗阻力並進行評分，以拉維特氏評量法(Lovett's Scale)來加以分級。	

主題名稱	肌力平衡測試評估	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A45	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明		
	肌肉強度的評量標準		
	等級	拉維特量表	描述
	5	正常(Normal； N)	病人在對抗正常的阻力及重力下，可完成全關節運動。
	4	好(Good； G)	病人在少許的阻力施加下，仍能完成全關節運動。
	3	稍好(Fair； F)	病人在沒有支撐而只有重力是其唯一阻力的情況下，能夠完成全關節運動。
	2	不良(Poor； P)	病人在關節受支撐以減少重力的情況下，可作全關節運動。
	1	差(Trace； T)	病人肌肉收縮可觸覺出，但沒有肌肉活動。
	0	零(Zero； O)	病人肌肉沒有可視或可觸的收縮跡象。
5. 執行下肢肌力評估：請病人左(右)腳往上屈曲，評估者自大腿試圖向下壓，請病人對抗阻力並進行評分，以拉維特氏評量法(Lovett's Scale)來加以分級。			

主題名稱	肌力平衡測試評估	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A45	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/5

步驟	說明
6. 評估步態平衡能力：當病人入院或轉入臥床時，第一次下床時應執行步態平衡測試，並衛教及教導病人及照顧者採漸進式下床。 A.步態平衡測試(Timed get up and go test, TUG)，於過程中觀察受檢者的穩定度與步態。 B.首先請受檢者坐在直背的椅子上，然後請病人站起，依照平常習慣速度往前走三公尺，轉身回到椅子上再坐下。 C.整個過程平均為 15 秒，若超過 20 秒，則需再次評估是否適合下床。	 坐在直背的椅子上 往前走 3 公尺 轉身回到椅子再坐下
7. 整理用物，洗手。	
8. 記錄：測試時間、結果、病人反應。	

(三) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 袁素娟(2022)・肌肉骨骼系統疾病之護理・於劉雪娥總校閱，*內外科護理學下冊*(八版，525-526 頁)・華杏。
- (二) Martín-Díaz, P., Carratalá-Tejada, M., Molina-Rueda, F., & Cuesta-Gómez, A. (2023). Reliability and agreement of the timed up and go test in children and teenagers with autism spectrum disorder. *European journal of pediatrics*, 182(8), 3577–3585.

主題名稱	肌力平衡測試評估	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A45	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/5

<https://doi.org/10.1007/s00431-023-05027-8>。

七、附件

(略)

主題名稱	肌力平衡測試評估	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A45	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
114.07.08	1.0	新制定。	114 年 06 月 11 日 護理長會議通過；114 年 07 月 08 日督導會議通過公布。